

Механизмы повышения доступности медицинской помощи на амбулаторном этапе (на примере городской поликлиники №1 Самарской области)

Золотарев Павел Николаевич
заместитель министра здравоохранения
министерства здравоохранения Самарской области
доктор медицинских наук, профессор кафедры



Проблематика

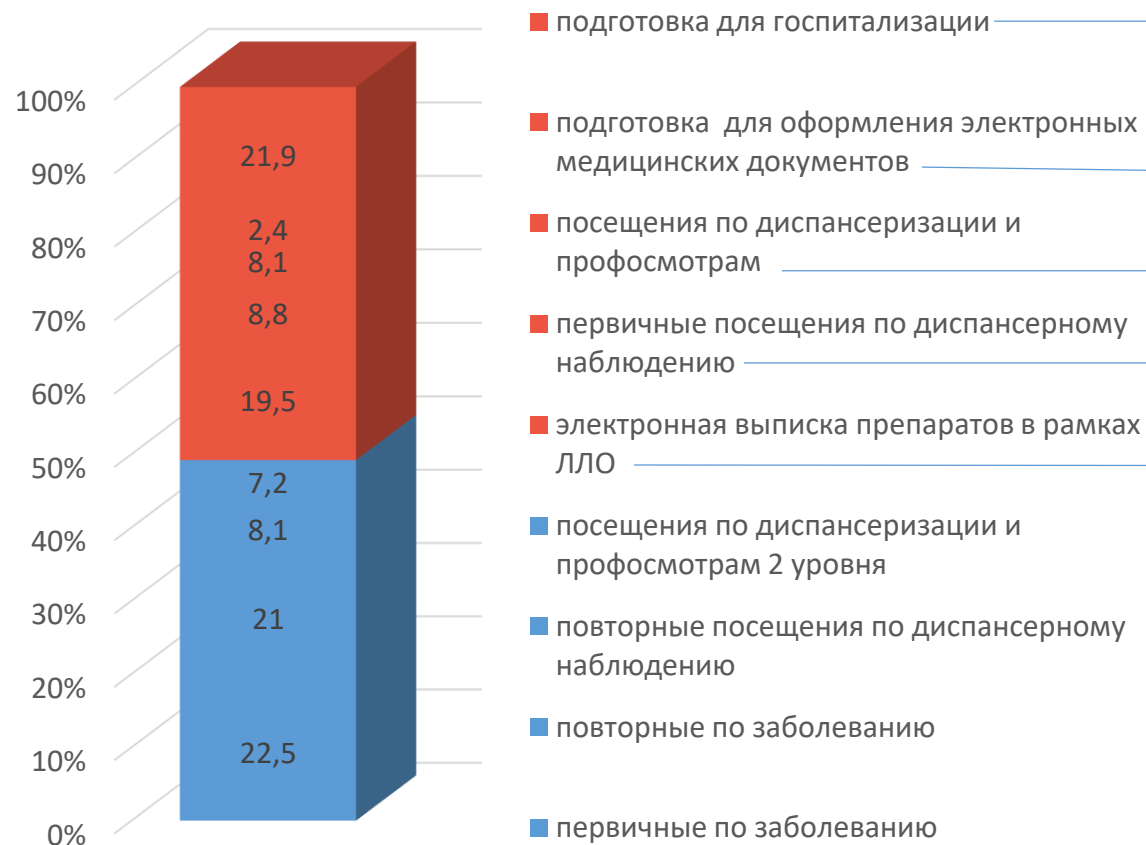
- Прогрессивно возрастающая потребность населения в услугах медицинской помощи, оказываемых на первичном этапе.
- Увеличение нагрузки на участковую службу, связанной с выполнением профилактических мероприятий в части диспансеризации и профилактических осмотров.
- Увеличение времени на оформление отчетно-учетной документации, в том числе в электронном виде.
- Недостаточная укомплектованность врачебными кадрами, в том числе врачами-специалистами на амбулаторном этапе.



Потребность в высвобождении времени врачей участковой службы и врачей-специалистов от немедицинской деятельности, профилактика «необоснованных посещений», обеспечение доступности первичной врачебной и первичной специализированной помощи



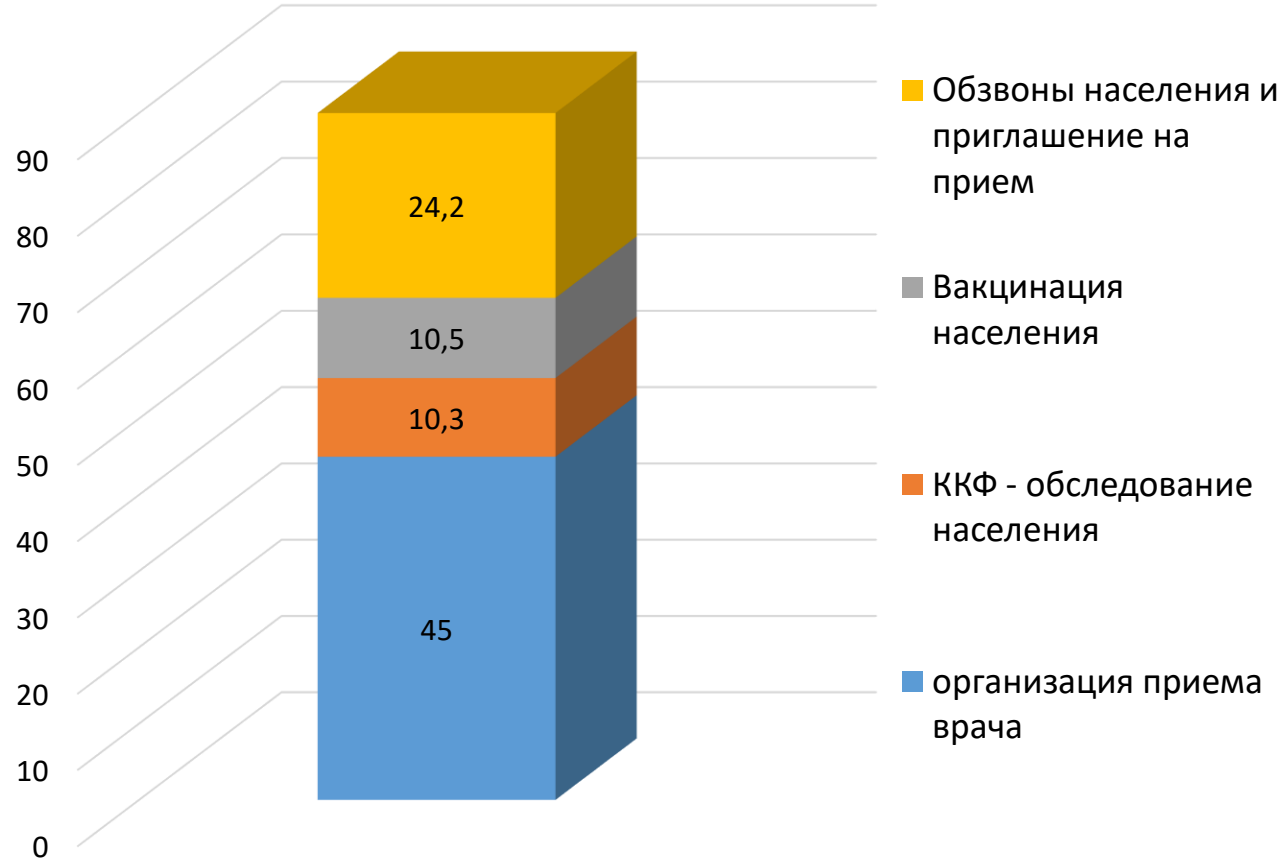
Анализ структуры приема врача участкового (по цели обращения) (на примере городской поликлиники №1 Самарской области)



До 18% посещений не требуют личного участия лечащего врача, либо оценка состояния пациента может быть проведена средним медицинским персоналом



Анализ структуры рабочего времени медсестры



До 25% рабочего времени связано с выполнением обязанностей, которые могут быть перераспределены на немедицинский персонал



Внесение изменений в должностные инструкции среднего медицинского персонала

Приказ Минздрава России от
23.07.2010 № 541н
«Об утверждении Единого
квалификационного
справочника должностей
руководителей,
специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные
характеристики должностей
работников в сфере
здравоохранения»



Приказ Минздрава России от
10.02.2016 № 83н
«Об утверждении
Квалификационных
требований к медицинским и
фармацевтическим
работникам со средним
медицинским и
фармацевтическим
Образованием»



Локальные приказы
медицинских организаций,
регламентирующие
дополнение к типовым
должностным обязанностям
среднего медицинского
персонала



Основные условия успешной реализации модели самостоятельной деятельности медицинских сестер

Готовность администрации к самостоятельной деятельности медицинских сестер

- Знания особенностей сестринской деятельности
- Навыки и опыт управления качеством оказания медицинской помощи

Готовность персонала

- Достаточный уровень знаний и навыков
- Активная позиция при внедрении новых технологий
- Знания основных аспектов управления качеством оказания медицинской помощи
- Уверенность в объективности оценки своей деятельности.

Готовность материально-технической базы

- Оснащенность рабочего места современным оборудованием для исполнения всех требуемых мероприятий
- Наличие информационного сопровождения всех процессов деятельности.
- Наличие технологических стандартов выполнения манипуляций и алгоритмов ведения пациентов.



Организация самостоятельной деятельности медицинской сестры потребовала:

- внесение изменений в локальные нормативные акты;
- совершенствование непрерывного профессионального образования среднего медицинского персонала;
- создания алгоритмов деятельности медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе;
- отработки системы взаимодействия медицинских сестер с врачом общей практики и врачами-специалистами поликлиники;
- создания собственных и адаптация уже имеющихся технологических стандартов, что позволило значительно сократить число ошибок и несоответствий, повысив качество медицинских услуг, оказываемых медицинской сестрой;
- разработки системы дифференцированной оплаты труда, ориентированной на результат работы команды «врач-медицинская сестра» и призванной стимулировать дальнейшее самосовершенствование и самоорганизацию медицинских сестер;
- создания информационной поддержки сестринского процесса;
- развития института наставничества и адаптации на рабочем месте среди медицинских сестер.

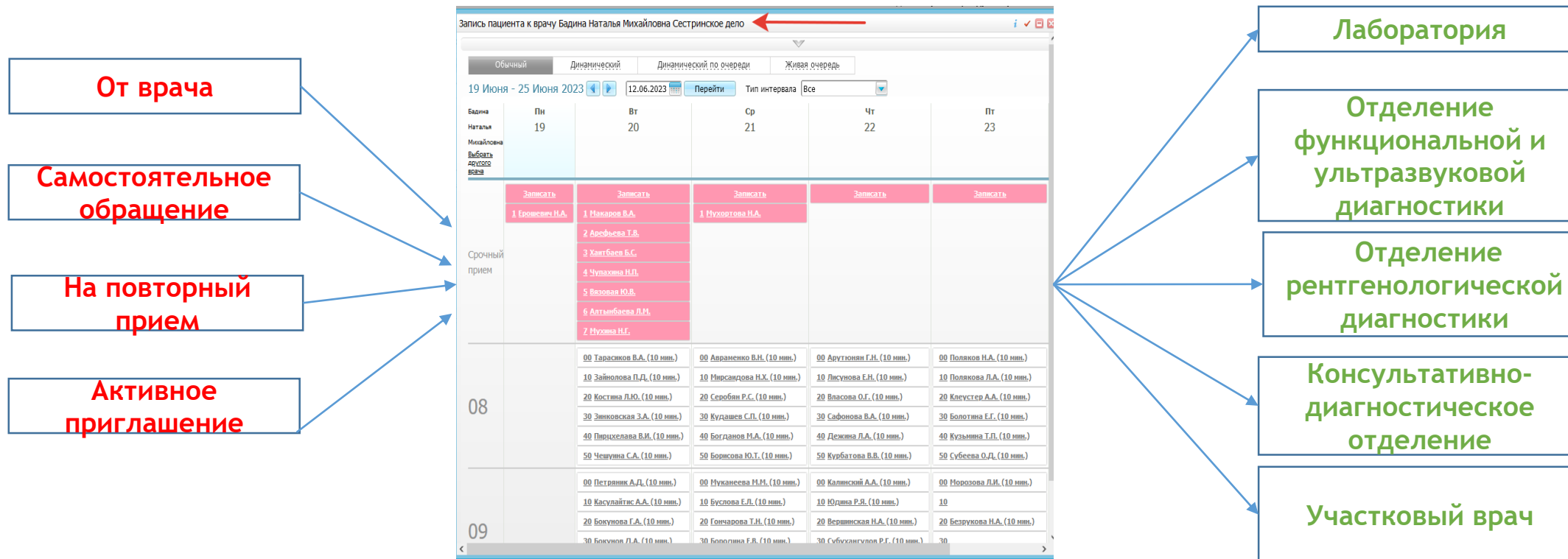


Поводы направления пациентов на самостоятельный прием к медицинским сестрам

- Подготовка к проведению диспансеризации и профилактических осмотров (активный вызов с участка, а также самостоятельное обращение)
- Подготовка к осмотру врача в рамках диспансерного наблюдения по заболеваниям (активный вызов с участка, а также самостоятельное обращение)
- Подготовка к плановой госпитализации (по направлению врача и самостоятельное обращение из регистратуры)
- Подготовка к оформлению санаторно-курортной карты и иных справок (по направлению врача и самостоятельное обращение из регистратуры)
- Подготовка к направлению документов на МСЭ (по направлению врача и самостоятельное обращение из регистратуры)
- Динамическое наблюдение за пациентами с ХНИЗ (по направлению врача)
- Выписка рецептов льготного отпуска (по направлению врача)



Формирование потоков пациентов на прием к медицинской сестре



Разработаны стандарты записи медицинской сестры в амбулаторной карте больного



Эффективность самостоятельного приема медицинских сестер врачей-специалистов



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Врач-офтальмолог
ежегодно **6000** посещений

Самостоятельный прием
медицинской сестры офтальмолога
+ 3610 визитов в год

Переданные функции:

Динамическое наблюдение за
больными глаукомой

Доврачебный осмотр

Подготовка к оперативному лечению

Доврачебный осмотр после
оперативного лечения

Скрининговые исследования

Выполнение манипуляций во время
ведения дневных офтальмологических
стационаров

Доврачебный осмотр после
оперативного лечения

Оформление рецептов

Посещение пациентов на дому

Врач-эндокринолог
ежегодно около **6900** посещений

Самостоятельный прием
эндокринологической медицинской
сестры
+ 1410 визитов в год

Переданные функции:

Формирование потока на ККФ, смотровые
кабинеты, вакцинацию

Доврачебный осмотр

Скрининговые исследования

Индивидуальное обучение и проведение
обучающих школ

Мониторинг эффективности
медикаментозной терапии

Обучение использованию пациентами
кислородоконцентраторов и небулайзеров.

Врач-хирург
ежегодно около **25000** посещений

Самостоятельный прием
медицинской сестры хирургической
+ 3 913 визитов в год

Переданные функции:

Самостоятельные повторные перевязки

Ведение стационаров на дому

Индивидуальное обучение по программе
«Диабет стопа»

Наблюдение за нетранспортабельными
больными и пациентами с пролежнями



Эффективность внедрение самостоятельного приема средним медицинским персоналом



За 5 месяцев 2023 года врачами выполнено 203 000 посещений
Средним медицинским персоналом выполнено +38 500 посещений

Доступность первичной врачебной помощи увеличилась на 18,8% за счет сокращения посещений к врачам, исключения визитов, не требующих врачебного участия.



Риски самостоятельного приема медицинских сестер

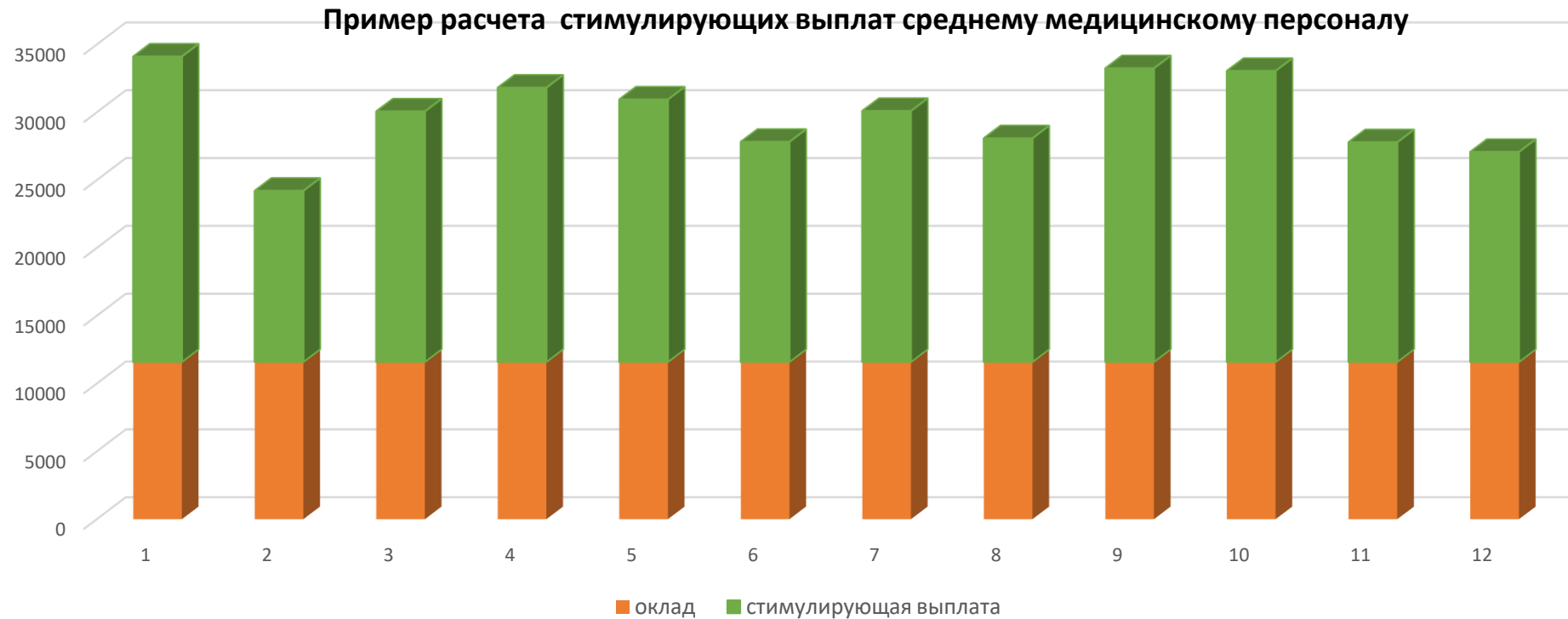
Риск	Мероприятия по предупреждению и устранению последствий
Недостаточные знания медицинских сестер по решению клинических и организационных проблем пациента	Непрерывное обучение медицинских сестер и команда «врач - медицинская сестра»
Отступление от алгоритмизации и стандартов работы	Контроль деятельности в зависимости от повода обращения пациента
Неверная интерпретация полученных результатов (пропуск патологии)	Непрерывное обучение медицинских сестер и команды «врач-медицинская сестра»
Низкая заинтересованность среднего медицинского персонала в достижении целевых показателей деятельности	Создание системы внутреннего контроля качества с формированием экономической заинтересованности



Дифференцированный подход к оплате труда медицинских сестер

Основные принципы:

1. Оценка работы команды «врач-медицинская сестра».
2. Обеспечение объективности, достоверности и сравнимости показателей, используемых для оценки деятельности.
3. Прозрачность экономических подсчетов.
4. Обязательное информирование сотрудников о выбранных критериях и полученных результатах.



Благодарю за внимание

